Sospecha y evaluación inicial

1. Identificar el patrón

Investigar infecciones graves, atípicas, recurrentes; autoinmunidad, citopenias, inflamación y antecedentes familiares.

Señal de urgencia

Lactante con oportunistas, linfopenia importante o falla de medro: considerar SCID y derivar con urgencia.

2. Pruebas contextualizadas

Etapa inicial

Historia y exploración, hemograma con diferencial y cuentas absolutas ajustadas a edad.

Según fenotipo

IgG, IgA, IgM, evaluación funcional de anticuerpos, T/B/NK, DHR, complemento o genética.

Considerar causas secundarias y evitar conclusiones basadas en un único dato normal.

FUENTES: primaryimmune.org | info4pi.org | fumeni.org.mx

Hoja de referencia para imprimir

3. Completa antes de derivar

Fecha	Situación o estudio	Notas

4. Verificación clínica

[ ] Historia de infecciones y antecedentes familiares.

[ ] Resultados e intervalos de referencia por edad.

[ ] Causas secundarias y urgencia consideradas.

[ ] Pruebas y plan de referencia individualizados.

Importante

Guía orientativa, no es un algoritmo clínico validado. La selección e interpretación de estudios corresponden al profesional tratante.

Fuentes: Immune Deficiency Foundation, Jeffrey Modell Foundation y FUMENI.

FUENTES: primaryimmune.org | info4pi.org | fumeni.org.mx